HAZIR TEDAVİ PLANI™ · ANA MATERYAL

# 40 Vaka Tipi İçin Hazır Tedavi Planı

Teşhisten pekiştirmeye, her vaka tipi için 4 aşamalı hazır iskelet: muayene biter bitmez planı açın, hastanın kayıtlarıyla uyarlayın.

Ortodontistin Başucu Kitabı

# İçindekiler


Nasıl kullanılır

40 planın dizini

Bölüm A · Sınıf I · Çapraşıklık, boşluk ve protrüzyon

Bölüm B · Transversal problemler · Çapraz kapanış

Bölüm C · Sınıf II vakalar

Bölüm D · Sınıf III vakalar

Bölüm E · Vertikal problemler · Açık ve derin kapanış

Bölüm F · Diş ve yer problemleri

Bölüm G · Erişkin, disiplinler arası ve özel vakalar

# Nasıl kullanılır

> *Her plan, Başucu Kitabı'ndaki **4 Aşamalı Klinik Planlayıcı** ile aynı sırada yazıldı: teşhis ve kayıt, hedef ve karar, mekanik sıra, bitirme ve pekiştirme. Muayene bittiğinde vakanın tipini bulun, planı açın ve hastanın kendi kayıtlarıyla uyarlayın.*

1. Vakayı sagital, vertikal, transversal ve yer problemi olarak sınıflandırın (Hızlı bonus: Vaka Tipi Seçici).
2. Dizinden en yakın plan numarasını bulun.
3. Teşhis ve kayıt adımlarını hastanın kayıtlarıyla tamamlayın.
4. Hedefleri ve kararı hasta dosyasına yazın.
5. Mekanik sırayı seans planınıza aktarın.
6. Bitirme ve pekiştirme maddelerini söküm gününden önce kontrol edin.

**Önemli:** Bu planlar başlangıç iskeletidir. Kuvvet, tel boyutu, aparey ayarı ve süreler hastanın kayıtlarına, büyüme durumuna ve sizin klinik kararınıza göre belirlenir.

# 40 planın dizini

## A · Sınıf I · Çapraşıklık, boşluk ve protrüzyon


01 Sınıf I · Hafif çapraşıklık
02 Sınıf I · Orta çapraşıklık
03 Sınıf I · Şiddetli çapraşıklık (çekimli plan)
04 Boşluklu ark (genel diastemalar)
05 Üst orta hat diastema
06 Bimaksiller protrüzyon


## B · Transversal problemler · Çapraz kapanış


07 Tek diş anterior çapraz kapanış
08 Tek taraflı posterior çapraz kapanış (fonksiyonel kayma)
09 Büyüme döneminde bilateral maksiller darlık
10 Erişkinde transversal darlık


## C · Sınıf II vakalar


11 Sınıf II/1 · Büyüme döneminde mandibuler retrüzyon
12 Sınıf II/1 · Erişkinde kamuflaj
13 Sınıf II/2 · Derin kapanış
14 Dental Sınıf II · Molar distalizasyonu
15 Tek taraflı Sınıf II (subdivizyon)
16 Erken müdahale · Artmış overjet ve dudak yetersizliği


## D · Sınıf III vakalar


17 Psödo Sınıf III (fonksiyonel)
18 Büyüme döneminde maksiller retrüzyon
19 Erişkinde hafif Sınıf III kamuflaj
20 Ortognatik cerrahi öncesi ortodontik hazırlık


## E · Vertikal problemler · Açık ve derin kapanış


21 Çocukta alışkanlığa bağlı açık kapanış
22 Erişkinde dentoalveolar açık kapanış
23 İskeletsel açık kapanış (hiperdiverjan)

| | |
|---|---|
| 24 | Derin kapanış (hipodiverjan) |
| 25 | Derin kapanış ve fazla dişeti görünümü |

## F · Diş ve yer problemleri

| | |
|---|---|
| 26 | Gömülü üst kanin |
| 27 | Konjenital eksik üst lateral |
| 28 | Konjenital eksik alt ikinci premolar |
| 29 | Erken süt dişi kaybı · Yer tutucu |
| 30 | Molar dikleştirme (protez öncesi) |
| 31 | Birinci molarda ektopik erüpsiyon |
| 32 | Süpernümerer diş ve gecikmiş erüpsiyon |

## G · Erişkin, disiplinler arası ve özel vakalar

| | |
|---|---|
| 33 | Periodontal problemli erişkin hasta |
| 34 | İmplant öncesi yer düzenleme |
| 35 | Nüks · Alt kesici çapraşıklığı |
| 36 | Bolton uyumsuzluğu (küçük lateraller) |
| 37 | Orta hat sapması |
| 38 | Erişkinde sınırlı (ön bölge) tedavi |
| 39 | Karma dişlenmede ön bölge düzeltmesi (2×4) |
| 40 | Alt kesici çapraşıklığı · IPR ile çözüm |

# Bölüm A · Sınıf I · Çapraşıklık, boşluk ve protrüzyon

## PLAN 01 Sınıf I · Hafif çapraşıklık

**Tipik bulgular:** Molar ve kanin ilişkisi Sınıf I, iskeletsel ilişki dengeli, ark boyu uyumsuzluğu hafif; profil kabul edilebilir.

**Tedavi hedefleri:** Çapraşıklığı çekimsiz çözmek · Kesici eğimini korumak · Mevcut profili bozmamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Model analizi ile yer ihtiyacını hesaplayın
- Kesici eğimini sefalometride kaydedin
- Dişeti biyotipini ve labial kemik desteğini not edin

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Çekimsiz plan; yer kaynağı olarak gerekiyorsa sınırlı IPR
- Proklinasyon sınırını tedavi başında belirleyin

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Tam ark braketleme veya şeffaf plak planı
2. Hafif, esnek tellerle seviyeleme
3. Gerekirse arka bölgelerde kontrollü IPR
4. Çalışma teline geçip ark formunu oturtun

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kontakt noktaları ve marjinal sırtları kontrol edin
- Alt ön bölge için sabit lingual retainer değerlendirin

**Sık hata:** Yer ihtiyacını ölçmeden seviyelemeye başlayıp kesicileri fark etmeden ileri itmek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 02 Sınıf I · Orta çapraşıklık

**Tipik bulgular:** Sınıf I ilişki; ark boyu uyumsuzluğu belirgin, kesici eğimi normal ya da hafif artmış.

**Tedavi hedefleri:** Yer kaynağını bilinçli seçmek · Kesici pozisyonunu kontrol altında tutmak · Kapanışı korumak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Yer analizi + sefalometri + profil fotoğrafı
- Dudak desteğini ve nazolabial açıyı değerlendirin
- Dişeti ve kemik sınırlarını not edin

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Yer kaynağı sırası: IPR, sınırlı genişletme, distalizasyon, son seçenek çekim
- Kararı Araç 2 · Çekim mi, Koruma mı? haritasıyla doğrulayın

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Braketleme ve hafif tellerle seviyeleme
2. Seçilen yer kaynağını uygulayın
3. Ark formunu koruyarak çalışma teline geçin
4. Orta hattı ve kapanışı kontrol edin

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Bitirme bükümleri ve detaylandırma
- Alt ve üst için retainer planı

**Sık hata:** Yer kaynağına karar vermeden tedaviye başlayıp yolun ortasında plan değiştirmek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 03 Sınıf I · Şiddetli çapraşıklık (çekimli plan)

**Tipik bulgular:** Sınıf I ilişki; ark boyu uyumsuzluğu çekimsiz çözülemeyecek düzeyde, kesiciler önde veya dudak desteği fazla.

**Tedavi hedefleri:** Çapraşıklığı çekimle çözmek · Kesici pozisyonunu iyileştirmek · Ankrajı kontrol etmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Tam kayıt seti: modeller, panoramik, sefalometrik, fotoğraflar
- Hangi dişin çekileceğini diş sağlığı ve ankraj ihtiyacına göre belirleyin

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Çekim kararı ve ankraj sınıfı (maksimum, orta, minimum)
- Gerekirse mini vida veya transpalatal ark ile ankraj

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Çekim sonrası seviyeleme ve kaninlerin distalizasyonu
2. Kesicilerin geri alınması veya en masse boşluk kapama
3. Ankrajı her kontrolde molar ilişkisiyle doğrulayın
4. Kök paralelliğini panoramikle kontrol edin

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Çekim bölgelerinde kök paralelliği
- Uzun süreli retainer planı

**Sık hata:** Ankraj sınıfını belirlemeden boşluk kapatmaya başlamak ve molar ilişkisini kaybetmek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 04 Boşluklu ark (genel diastemalar)

**Tipik bulgular:** Ark boyunca boşluklar, dişler ark boyuna göre küçük veya ark geniş; dil veya alışkanlık katkısı olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Boşlukları kapatmak ya da protetik için dağıtmak · Kesici eğimini kontrol etmek · Nüksü önlemek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Boşluk miktarı ve dağılımı
- Bolton analizi (diş boyutu uyumu)
- Dil pozisyonu ve alışkanlık sorgusu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Tam kapatma mı, protetik tamamlama için yer düzenleme mi? Restoratif hekimle birlikte karar
- Alışkanlık varsa önce onu ele alın

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Elastik zincir veya kapatma yayı ile boşluk kapama
3. Kesicilerin aşırı geri gelmesini izleyin
4. Gerekirse restorasyon için boşluk bırakın

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sabit retainer şart kabul edin
- Restorasyon yapılacaksa retainer'ı restorasyon sonrasına göre planlayın

**Sık hata:** Boşlukları kapatıp sabit retainer koymadan bitirmek.

**Detay:** Modül 08 · Bitirme ve stabilite

## PLAN 05 Üst orta hat diastema

**Tipik bulgular:** Üst santraller arasında boşluk; frenulum kalın veya düşük yapışmalı olabilir, süpernümerer diş ihtimali var.

**Tedavi hedefleri:** Diastemayı kapatmak · Nedeni ortadan kaldırmak · Nüksü önlemek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Periapikal veya panoramik ile meziodens kontrolü
- Frenulum blanşe testi
- Kesici eğimi ve diş boyutu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Neden varsa önce neden: meziodens, frenulum, alışkanlık
- Frenektomi zamanlamasını cerrahla planlayın (genelde kapatma sonrası)

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Santrallere bölgesel braket
2. Kökleri paralel tutarak boşluk kapama
3. Kapatma sonrası gerekirse frenektomi
4. Kontrol

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Palatinal sabit retainer
- Uzun süreli takip

**Sık hata:** Kökleri değil kronları yaklaştırıp kısa sürede nüks görmek.

**Detay:** Modül 08 · Bitirme ve stabilite

**Yönlendirme:** Meziodens veya kalın frenulum: ağız cerrahisi / periodontoloji.

## PLAN 06 Bimaksiller protrüzyon

**Tipik bulgular:** Sınıf I ilişki; alt ve üst kesiciler önde, dudaklar dolgun ve gergin, dudak kapanışında zorlanma olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Kesicileri geri almak · Dudak desteğini azaltmak · Ankrajı maksimum tutmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Sefalometrik kesici eğimleri ve dudak çizgileri
- Profil fotoğrafı ve hastanın estetik beklentisi
- Kemik desteği ve dişeti

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Genelde dört premolar çekimli plan
- Maksimum ankraj: mini vida veya ekstraoral destek seçenekleri

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Kanin distalizasyonu veya en masse geri alma
3. Tork kontrolü ile kesicilerin geri alınması
4. Profil değişimini fotoğrafla takip edin

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kök paralelliği ve tork
- Alt ve üst retainer

**Sık hata:** Tork kontrolü olmadan kesicileri geri almak ve devrilmiş kesicilerle bitirmek.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

# Bölüm B · Transversal problemler · Çapraz kapanış

## PLAN 07 Tek diş anterior çapraz kapanış

**Tipik bulgular:** Bir üst kesici altların arkasında; iskeletsel ilişki dengeli, kapanışta öne kayma olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Dişi çapraz kapanıştan çıkarmak · Fonksiyonel kaymayı ortadan kaldırmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Sentrik ilişki ile kapanış arasındaki kayma
- Dişin önünde yer var mı?
- Kök şekli ve kemik desteği

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Yer yeterliyse lokal düzeltme
- Yer yoksa önce yer açma

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Gerekirse ısırma yükseltici (kapanışı açmak için)
2. Bölgesel braket veya hareketli aparey ile dişi öne alma
3. Overbite oluşunca stabil kabul edin

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Yeterli overbite kontrolü
- Kısa süreli retainer

**Sık hata:** Kapanışı açmadan dişi zorlamak ve aparey kırılması.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

## PLAN 08 Tek taraflı posterior çapraz kapanış (fonksiyonel kayma)

**Tipik bulgular:** Bir tarafta çapraz kapanış, kapanışta mandibula yana kayıyor, orta hat sapması kapanışta artıyor.

**Tedavi hedefleri:** Kaymayı ortadan kaldırmak · Üst arkı simetrik genişletmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Ağız açıkken ve kapalıyken orta hat karşılaştırması
- Üst ark genişliği ve molar eğimi
- Büyüme dönemi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Gerçek tek taraflı mı, kayma ile oluşan mı? Ayırın
- Kayma varsa üst ark simetrik genişletme

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Genişletme apareyi (büyüme dönemine göre seçim)
2. Genişletme sonrası pekiştirme süresi
3. Gerekirse sabit tedaviyle detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Orta hat ve kapanış kontrolü
- Transversal retainer

**Sık hata:** Kaymayı görmeden tek taraflı asimetrik mekanik uygulamak.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

## PLAN 09 Büyüme döneminde bilateral maksiller darlık

**Tipik bulgular:** İki taraflı posterior çapraz kapanış veya dar üst ark, geniş bukkal koridorlar, burun solunumu sorgulanmalı.

**Tedavi hedefleri:** Üst çeneyi iskeletsel genişletmek · Ark boyuna yer kazanmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Büyüme ve sutur olgunluğu değerlendirmesi
- Okluzal veya panoramik kayıt
- Solunum ve alışkanlık sorgusu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Hızlı üst çene genişletme apareyi seçimi
- Solunum problemi varsa KBB görüşü

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Aparey uygulaması ve aktivasyon programı
2. Genişletme sonrası apareyi pasif bırakarak pekiştirme
3. Ardından sabit tedavi veya izlem

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Transversal stabilite
- Gerekirse gece retainer

**Sık hata:** Pekiştirme süresini kısa tutup genişlemenin geri dönmesi.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

**Yönlendirme:** Ağız solunumu ve horlama: KBB.

## PLAN 10 Erişkinde transversal darlık

**Tipik bulgular:** Erişkin hastada dar üst ark ve çapraz kapanış; suturlar olgun, dental kompanzasyon mevcut.

**Tedavi hedefleri:** Mümkün olan genişletmeyi seçmek · Periodontal sınırları korumak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Molar eğimleri ve bukkal kemik kalınlığı
- Dişeti çekilmesi riski
- Problem dental mı iskeletsel mi?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Dental genişletme sınırlı, iskeletsel darlıkta mini vida destekli genişletme veya cerrahi destek seçenekleri
- Kararı hastayla birlikte ve yazılı plan üzerinde verin

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seçilen genişletme yöntemi
2. Molar eğimini kontrol eden tel ve tork
3. Sabit tedaviyle detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Periodontal kontrol
- Transversal retainer

**Sık hata:** Dental genişletmeyle iskeletsel problemi çözmeye çalışıp dişleri bukkale devirmek.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

**Yönlendirme:** İskeletsel darlık: ağız, diş ve çene cerrahisi.

# Bölüm C · Sınıf II vakalar

## PLAN 11 Sınıf II/1 · Büyüme döneminde mandibuler retrüzyon

**Tipik bulgular:** Artmış overjet, Sınıf II molar, retrüziv mandibula, büyüme potansiyeli var.

**Tedavi hedefleri:** Büyümeyi yönlendirmek · Overjeti azaltmak · Kesici travma riskini düşürmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Büyüme dönemi değerlendirmesi
- Sefalometride iskeletsel ve dental bileşenler
- Hastanın uyum kapasitesi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Fonksiyonel aparey zamanlaması büyüme atılımına göre
- Hareketli mi sabit fonksiyonel mi? Uyuma göre

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Fonksiyonel aparey dönemi
2. Kontrollerde molar ve overjet ölçümü
3. Ardından sabit tedavi ile detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sınıf I ilişkinin oturması
- Gece retainer veya aktivatör ile pekiştirme

**Sık hata:** Büyüme dönemini kaçırıp fonksiyonel tedaviye geç başlamak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

## PLAN 12 Sınıf II/1 · Erişkinde kamuflaj

**Tipik bulgular:** Erişkin, Sınıf II iskeletsel ilişki hafif–orta, overjet artmış, hasta cerrahi istemiyor.

**Tedavi hedefleri:** Overjeti dental hareketlerle kapatmak · Profili kabul edilebilir tutmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- İskeletsel farkın büyüklüğü
- Profil ve dudak analizi
- Hastanın estetik beklentisi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Kamuflaj sınırında mı? Sınırdaysa cerrahi seçeneği de anlatın
- Genelde üst premolar çekimli plan; ankraj planı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Üst kaninlerin distalizasyonu
3. Üst kesicilerin tork kontrollü geri alınması
4. Kanin Sınıf I, molar Sınıf II ile bitirme

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kesici torku ve overbite
- Retainer

**Sık hata:** Kamuflaj sınırını aşan vakada profil kötüleşene kadar devam etmek.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

**Yönlendirme:** Belirgin iskeletsel Sınıf II: ortognatik cerrahi görüşü.

## PLAN 13 Sınıf II/2 · Derin kapanış

**Tipik bulgular:** Üst santraller retrokline, lateraller önde olabilir, derin kapanış, güçlü dudak kası.

**Tedavi hedefleri:** Kesici eğimini düzeltmek · Derin kapanışı açmak · Sınıf II ilişkiyi düzeltmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Kesici eğimi ve overbite
- Dişeti görünümü ve gülüş çizgisi
- TME sorgusu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Önce kesici torkunu düzeltip ardından sagital problemi ele alın
- Büyüme varsa fonksiyonel aparey öncesi kesicileri açın

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Üst kesicilerin protrüzyonu ve tork
2. Kapanış açma mekaniği (intrüzyon veya posterior ekstrüzyon, vakaya göre)
3. Sınıf II düzeltme

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Overbite stabilitesi
- Üst palatinal retainer

**Sık hata:** Derin kapanışı açmadan Sınıf II elastik kullanıp kesicileri zorlamak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

## PLAN 14 Dental Sınıf II · Molar distalizasyonu

**Tipik bulgular:** İskeletsel ilişki dengeli, üst molarlar mezialde, Sınıf II molar, profil iyi.

**Tedavi hedefleri:** Molarları Sınıf I'e almak · Çekimsiz tedavi

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Molar arkasında yer var mı? (yirmi yaş dişleri)
- Vertikal yüz tipi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Distalizasyon apareyi veya mini vida destekli distalizasyon
- Ankraj kaybını önleme planı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Molar distalizasyonu
2. Premolar ve kaninlerin sırayla distalizasyonu
3. Ön bölgenin geri alınması

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sınıf I molar ve kanin
- Retainer

**Sık hata:** Distalizasyon sırasında ön bölgenin öne gitmesini (ankraj kaybı) gözden kaçırmak.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 15 Tek taraflı Sınıf II (subdivizyon)

**Tipik bulgular:** Bir tarafta Sınıf I, diğer tarafta Sınıf II; orta hat sapması eşlik edebilir.

**Tedavi hedefleri:** Asimetriyi düzeltmek · Orta hatları hizalamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Asimetri dental mi iskeletsel mi?
- Orta hatların yüze göre konumu
- Fonksiyonel kayma var mı?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Asimetrik çekim, asimetrik elastik veya tek taraflı distalizasyon
- İskeletsel asimetride cerrahi seçenek

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Simetrik seviyeleme
2. Seçilen asimetrik mekanik
3. Orta hat kontrolü her seansta

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Orta hat ve kanin ilişkisi
- Retainer

**Sık hata:** İskeletsel asimetriyi dental mekanikle zorlamak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

## PLAN 16 Erken müdahale · Artmış overjet ve dudak yetersizliği

**Tipik bulgular:** Karma dişlenme, belirgin overjet, dudaklar kesicileri örtmüyor, travma riski yüksek.

**Tedavi hedefleri:** Travma riskini azaltmak · Büyümeyi yönlendirmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Travma öyküsü
- Alışkanlıklar (parmak emme)
- Büyüme dönemi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Erken faz mı, ikinci faza mı bırakmalı? Risk ve uyuma göre
- Aileyle iki fazlı planı konuşun

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Alışkanlık kontrolü
2. Fonksiyonel aparey veya sınırlı sabit mekanik
3. İzlem ve ikinci faz zamanlaması

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kazanımları koruyan retainer
- İkinci faz değerlendirmesi

**Sık hata:** Erken fazı uzatıp hastayı ve aileyi yormak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

# Bölüm D · Sınıf III vakalar

## PLAN 17 Psödo Sınıf III (fonksiyonel)

**Tipik bulgular:** Kapanışta öne kayma, sentrik ilişkide başa baş kesiciler, iskeletsel ilişki normal.

**Tedavi hedefleri:** Kaymayı ortadan kaldırmak · Kesicileri normal overjete almak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Sentrik ilişki ile kapanış farkı
- Kesici eğimleri
- Aile öyküsü

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Erken düzeltme genelde avantajlı
- Basit mekanik yeterli olabilir

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Üst kesicilerin öne alınması
2. Gerekirse ısırma yükseltici
3. Pozitif overjet ve overbite oluşunca bitirme

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Overbite kontrolü
- Büyüme takibi

**Sık hata:** Gerçek iskeletsel Sınıf III'ü psödo sanmak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

## PLAN 18 Büyüme döneminde maksiller retrüzyon

**Tipik bulgular:** İskeletsel Sınıf III, retrüziv maksilla, karma dişlenme veya erken daimi dişlenme.

**Tedavi hedefleri:** Maksiller gelişimi desteklemek · Pozitif overjet elde etmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Büyüme dönemi
- Sefalometride maksilla ve mandibula konumu
- Aile öyküsü ve prognoz

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Yüz maskesi (gerekirse genişletmeyle) erken dönemde
- Aileye nüks ve olası cerrahi ihtimalini baştan anlatın

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Gerekirse üst çene genişletme
2. Yüz maskesi programı
3. Aşırı düzeltme ve izlem

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Büyüme sonuna kadar takip
- Gerekirse ikinci faz

**Sık hata:** Prognozu aileye anlatmadan başlayıp ileride cerrahi ihtiyacını sürpriz yapmak.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

## PLAN 19 Erişkinde hafif Sınıf III kamuflaj

**Tipik bulgular:** Erişkin, hafif iskeletsel Sınıf III, başa baş veya hafif negatif overjet, profil kabul edilebilir.

**Tedavi hedefleri:** Pozitif overjet · Kesici eğimlerini kabul edilebilir sınırda tutmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- İskeletsel farkın büyüklüğü
- Alt kesici kemik desteği
- Hasta beklentisi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Kamuflaj sınırını değerlendirin; sınırdaysa cerrahi seçeneği anlatın
- Alt arkta yer kaynağı: IPR, çekim veya distalizasyon

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Sınıf III mekaniği (elastik veya mini vida destekli)
3. Kesici torkunun kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Overbite ve overjet
- Retainer

**Sık hata:** Alt kesicileri kemik dışına çıkacak kadar geri devirmek.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

**Yönlendirme:** Belirgin iskeletsel Sınıf III: ortognatik cerrahi.

## PLAN 20 Ortognatik cerrahi öncesi ortodontik hazırlık

**Tipik bulgular:** Belirgin iskeletsel uyumsuzluk, dental kompanzasyon var, hasta cerrahiye açık.

**Tedavi hedefleri:** Dekompanzasyon · Arkları birbirine uyumlu hale getirmek · Cerrahiye hazır kayıtlar

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Tam kayıt seti ve cerrahla ortak değerlendirme
- Kompanzasyonun yönü

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Cerrahi plan cerrahla birlikte; ortodontinin işi dekompanzasyon ve ark uyumu
- Çekim gerekiyorsa dekompanzasyon yönünde

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme ve dekompanzasyon
2. Arkların koordinasyonu
3. Cerrahi öncesi model ve kayıt
4. Cerrahi sonrası detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kapanış oturması
- Retainer

**Sık hata:** Kompanzasyonu artırarak hastayı cerrahiye daha zor hale getirmek.

**Detay:** Modül 05 · Sagital problemler

**Yönlendirme:** Ağız, diş ve çene cerrahisi ile ortak plan.

# Bölüm E · Vertikal problemler · Açık ve derin kapanış

## PLAN 21 Çocukta alışkanlığa bağlı açık kapanış

**Tipik bulgular:** Karma dişlenme, anterior açık kapanış, parmak emme veya dil itimi öyküsü.

**Tedavi hedefleri:** Alışkanlığı bırakmak · Kesicilerin kendiliğinden kapanmasına izin vermek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Alışkanlık öyküsü ve sıklığı
- Dil pozisyonu ve yutkunma
- İskeletsel bileşen var mı?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Önce alışkanlık; aparey hatırlatıcıdır, ceza değildir
- Gerekirse miyofonksiyonel destek

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Alışkanlık kırıcı aparey (vakaya göre)
2. Dil egzersizleri
3. Kapanmanın izlenmesi

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Alışkanlık nüksünü izleyin
- İkinci faz değerlendirmesi

**Sık hata:** Alışkanlığı çözmeden sabit mekanikle kapanışı kapatmaya çalışmak.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

**Yönlendirme:** Dil ve yutkunma problemi: miyofonksiyonel terapi / KBB.

## PLAN 22 Erişkinde dentoalveolar açık kapanış

**Tipik bulgular:** Erişkin, anterior açık kapanış, iskeletsel yapı görece normal, dil pozisyonu katkısı olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Açık kapanışı kapatmak · Stabiliteyi sağlamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Dental ve iskeletsel bileşen ayrımı
- Dil pozisyonu
- Kesici-dudak ilişkisi ve gülüş

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Posterior intrüzyon (mini vida destekli) veya anterior ekstrüzyon: gülüşe göre seçim
- Dil eğitimi planı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Seçilen vertikal mekanik
3. Overbite kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Dil alışkanlığı kontrolü
- Uzun süreli retainer

**Sık hata:** Kesicileri aşırı uzatıp gülüşü ve stabiliteyi bozmak.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

## PLAN 23 İskeletsel açık kapanış (hiperdiverjan)

**Tipik bulgular:** Uzun alt yüz yüksekliği, dik mandibuler düzlem, anterior açık kapanış.

**Tedavi hedefleri:** Vertikal kontrol · Kapanışı kapatmak veya cerrahiye hazırlamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Vertikal sefalometrik ölçümler
- Dudak yetersizliği ve dişeti görünümü

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Kamuflaj (posterior intrüzyon) mı, cerrahi mi? İskeletsel farka göre
- Ekstrüzyon yapan mekaniklerden kaçının

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Vertikal ankraj kontrolü
2. Mini vida ile posterior intrüzyon (seçilirse)
3. Detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Vertikal stabilite
- Retainer

**Sık hata:** Sınıf II veya III elastiklerle molarları uzatıp açık kapanışı büyütmek.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

**Yönlendirme:** Belirgin iskeletsel açık kapanış: ortognatik cerrahi.

## PLAN 24 Derin kapanış (hipodiverjan)

**Tipik bulgular:** Kısa alt yüz, derin kapanış, güçlü çiğneme kasları.

**Tedavi hedefleri:** Derin kapanışı açmak · Stabil bir overbite

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Vertikal ölçümler ve gülüş çizgisi
- Alt kesicilerin üst palatinal dokuya teması

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Posterior ekstrüzyon bu yüz tipinde daha uygun olabilir
- Kesici intrüzyonu gülüşe göre

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Isırma yükseltici
2. Ters eğrili tellerle kapanış açma
3. Overbite kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Üst palatinal retainer ile ısırma koruması
- Overbite takibi

**Sık hata:** Kapanışı açmadan alt braketleri yapıştırıp braket kırılmalarıyla uğraşmak.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

## PLAN 25 Derin kapanış ve fazla dişeti görünümü

**Tipik bulgular:** Derin kapanış, gülüşte fazla dişeti görünümü, üst kesiciler uzamış.

**Tedavi hedefleri:** Üst kesicileri intrüze etmek · Gülüş estetiğini iyileştirmek

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Dinlenmede ve gülüşte kesici görünümü
- Dudak boyu ve hareketliliği
- Dişeti sebepli mi dental mi?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Üst kesici intrüzyonu (mini vida veya intrüzyon arkı)
- Dişeti nedenli ise periodontal görüş

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Üst kesici intrüzyonu
3. Tork kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Gülüş fotoğrafıyla son kontrol
- Retainer

**Sık hata:** Kesicileri intrüze ederken torku kaybedip kökleri palatinale devirmek.

**Detay:** Modül 06 · Vertikal ve transversal problemler

**Yönlendirme:** Dişeti fazlalığı: periodontoloji.

# Bölüm F · Diş ve yer problemleri

## PLAN 26 Gömülü üst kanin

**Tipik bulgular:** Kanin sürmemiş, süt kanin yerinde olabilir, palatinal veya bukkal konum.

**Tedavi hedefleri:** Kanini arka sürdürmek · Komşu kökleri korumak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Konumun 3B değerlendirmesi (gerekirse KIBT)
- Lateral kök rezorpsiyonu kontrolü
- Yer var mı?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Cerrahi açma + traksiyon mu, çekim mi? Konum ve prognoza göre
- Cerrahla ortak plan

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Önce yer açma ve sağlam ankraj teli
2. Cerrahi açma ve ataşman
3. Hafif kuvvetle traksiyon
4. Arka alma ve tork

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Dişeti durumu ve kök pozisyonu
- Retainer

**Sık hata:** Yer açmadan ve ankraj teli olmadan traksiyona başlayıp komşu dişleri kaydırmak.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

**Yönlendirme:** Ağız cerrahisi (açma) ve gerekirse KIBT için radyoloji.

## PLAN 27 Konjenital eksik üst lateral

**Tipik bulgular:** Bir veya iki üst lateral yok; kaninler mezialde olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Boşluk açma (implant/protez) veya boşluk kapama (kanin şekillendirme) kararı

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Kanin rengi, şekli ve dişeti seviyesi
- Kapanış ilişkisi
- Hastanın yaşı ve restoratif seçenekler

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Restoratif hekimle birlikte karar: açma mı kapama mı?
- Karar yazılı plan olarak hastaya verilsin

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seçilen yönde mekanik: boşluk açma veya kapama
2. Kanin ve premolar şekillendirme planı
3. Kök paralelliği

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Restorasyon zamanlamasına göre geçici çözüm
- Retainer

**Sık hata:** Restoratif hekime danışmadan boşluk miktarına karar vermek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

**Yönlendirme:** Protetik / implant hekimi.

## PLAN 28 Konjenital eksik alt ikinci premolar

**Tipik bulgular:** Alt ikinci premolar yok, süt molar yerinde olabilir.

**Tedavi hedefleri:** Süt molarını koruma, boşluk kapama veya protetik çözüm kararı

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Süt molarının kök durumu ve infraokluzyonu
- Profil ve çapraşıklık durumu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Çapraşıklık varsa boşluk kapama avantajlı olabilir
- Süt molar iyi durumdaysa korunabilir

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seçilen plan: kapama veya koruma
2. Kapamada molar ankraj kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kapanış ve kök paralelliği
- Retainer

**Sık hata:** Süt molarının infraokluzyonunu izlemeden yıllarca beklemek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 29 Erken süt dişi kaybı · Yer tutucu

**Tipik bulgular:** Süt molar erken kaybedilmiş, alttaki daimi diş henüz sürmemiş.

**Tedavi hedefleri:** Yeri korumak · Daimi dişin normal sürmesi

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Daimi diş tomurcuğunun konumu
- Yer kaybı başlamış mı?

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Yer tutucu tipi (sabit/hareketli) ve süresi
- Yer kaybı varsa yer kazanma planı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Yer tutucu uygulaması
2. Düzenli kontrol
3. Daimi diş sürünce sökme

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sürme takibi

**Sık hata:** Yer tutucuyu takipsiz bırakıp daimi dişin sürmesini engellemek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 30 Molar dikleştirme (protez öncesi)

**Tipik bulgular:** Erişkin, alt molar boşluğa doğru devrilmiş, protez veya implant planlanıyor.

**Tedavi hedefleri:** Molari dikleştirmek · Protez için paralel yer açmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Periodontal durum ve kemik
- Karşıt dişin uzaması

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Bölgesel mekanik yeterli mi?
- Protez hekimiyle yer miktarı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Bölgesel braketleme ve ankraj
2. Dikleştirme yayı veya mini vida destekli mekanik
3. Okluzal kontrol

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Protez veya implant sonrası retainer gereksinimi

**Sık hata:** Dikleştirme sırasında molari uzatıp okluzal travma oluşturmak.

**Detay:** Modül 07 · Yardımcı mekanikler

**Yönlendirme:** Protez / implant hekimi ve periodontoloji.

## PLAN 31 Birinci molarda ektopik erüpsiyon

**Tipik bulgular:** Üst birinci molar süt ikinci molarının distal köküne takılmış.

**Tedavi hedefleri:** Molarin sürmesini sağlamak · Süt molarını mümkünse korumak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Panoramik ile takılmanın derecesi
- Süt molar rezorpsiyonu

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Kendiliğinden düzelme ihtimali için kısa izlem mi, müdahale mi?

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Ayırıcı veya basit distalizasyon apareyi
2. Sürme sonrası kontrol

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Yer kaybı kontrolü

**Sık hata:** Uzun süre izleyip süt molarının ve yerin kaybedilmesi.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

## PLAN 32 Süpernümerer diş ve gecikmiş erüpsiyon

**Tipik bulgular:** Bir daimi diş süremedi, bölgede süpernümerer diş var.

**Tedavi hedefleri:** Engeli kaldırmak · Dişin sürmesini sağlamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Radyografik lokalizasyon
- Kök gelişimi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Süpernümerer çekimi ve izlem mi, çekim + açma mı? Cerrahla karar

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Yer açma ve koruma
2. Cerrahi
3. Gerekirse traksiyon

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kök ve dişeti durumu
- Retainer

**Sık hata:** Yer açmadan cerrahi yapıp dişin sürmesini beklemek.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

**Yönlendirme:** Ağız cerrahisi.

# Bölüm G · Erişkin, disiplinler arası ve özel vakalar

## PLAN 33 Periodontal problemli erişkin hasta

**Tipik bulgular:** Kemik kaybı, migre olmuş ve yelpazelenmiş kesiciler, periodontal tedavi görmüş veya gerekiyor.

**Tedavi hedefleri:** Dişleri hafif kuvvetle hizalamak · Periodontal sağlığı korumak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Güncel periodontal durum ve stabilite
- Kemik seviyeleri

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Periodontal tedavi tamamlanmadan başlamayın
- Hafif kuvvet, basit mekanik

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Periodontal onay
2. Hafif kuvvetli seviyeleme
3. Sık periodontal kontrol

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Kalıcı sabit retainer
- Periodontal bakım programı

**Sık hata:** Aktif periodontal hastalıkta ortodontik kuvvet uygulamak.

**Detay:** Modül 07 · Yardımcı mekanikler

**Yönlendirme:** Periodontoloji ile ortak takip.

## PLAN 34 İmplant öncesi yer düzenleme

**Tipik bulgular:** Eksik diş bölgesinde yer yetersiz veya kökler eğik, implant planlanıyor.

**Tedavi hedefleri:** Kron ve kök seviyesinde yeterli yer · Paralel komşu kökler

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Gereken yer miktarı implant hekimiyle
- Kök paralelliği radyografisi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Yer açma mekaniği ve geçici çözüm

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Bölgesel veya tam ark mekanik
2. Kök paralelliği kontrolü
3. İmplant zamanına kadar yer koruma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Geçici protez ve retainer
- İmplant sonrası kontrol

**Sık hata:** Sadece kron seviyesinde yer açıp kökleri yaklaştırmak.

**Detay:** Modül 07 · Yardımcı mekanikler

**Yönlendirme:** İmplant hekimi.

## PLAN 35 Nüks · Alt kesici çapraşıklığı

**Tipik bulgular:** Daha önce ortodontik tedavi görmüş, retainer kullanılmamış, alt kesicilerde yeni çapraşıklık.

**Tedavi hedefleri:** Çapraşıklığı yeniden düzeltmek · Bu sefer kalıcı pekiştirme

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Önceki tedavi ve retainer öyküsü
- Yer ihtiyacı

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Sınırlı tedavi (şeffaf plak veya bölgesel braket) çoğu zaman yeterli
- IPR gerekebilir

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Bölgesel hizalama
2. Gerekirse IPR
3. Sabit retainer

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sabit lingual retainer şart
- Retainer kontrol programı

**Sık hata:** Tekrar düzeltip yine retainer planı yapmamak.

**Detay:** Modül 08 · Bitirme ve stabilite

## PLAN 36 Bolton uyumsuzluğu (küçük lateraller)

**Tipik bulgular:** Üst lateraller küçük veya konik, ön bölgede boşluk veya overjet uyumsuzluğu.

**Tedavi hedefleri:** Ön bölgede uyumlu kapanış · Estetik

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Bolton analizi
- Restoratif seçenekler

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Boşlukları lateraller çevresinde dağıtıp restorasyon mu, IPR mı? Restoratif hekimle

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Hizalama
2. Boşluk dağıtımı
3. Restorasyon sonrası detaylandırma

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Restorasyon sonrası retainer

**Sık hata:** Bolton uyumsuzluğunu hesaplamadan ön bölgeyi kapatıp overjeti bozmak.

**Detay:** Modül 08 · Bitirme ve stabilite

**Yönlendirme:** Restoratif / estetik diş hekimi.

## PLAN 37 Orta hat sapması

**Tipik bulgular:** Üst ve alt orta hat birbirine veya yüze göre kaymış.

**Tedavi hedefleri:** Orta hatları hizalamak · Nedeni bulmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Hangi orta hat kaymış? Yüze göre
- Fonksiyonel kayma, asimetrik çapraşıklık veya eksik diş

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Nedene göre: asimetrik çekim, asimetrik elastik, boşluk dağıtımı

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Seviyeleme
2. Seçilen asimetrik mekanik
3. Her seansta orta hat ölçümü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Orta hat ve kanin ilişkisi
- Retainer

**Sık hata:** Yüz orta hattına bakmadan dişleri birbirine göre hizalamak.

**Detay:** Modül 03 · Klinik planlama

## PLAN 38 Erişkinde sınırlı (ön bölge) tedavi

**Tipik bulgular:** Erişkin, sadece ön bölgedeki estetik sorundan şikâyetçi, posterior kapanış iyi.

**Tedavi hedefleri:** Ön bölgeyi düzeltmek · Posterior kapanışı bozmamak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Problem gerçekten sınırlı mı?
- Yer ihtiyacı ve kapanış

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Sınırlı tedavinin sınırlarını hastaya yazılı anlatın
- Şeffaf plak veya bölgesel sabit mekanik

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Bölgesel hizalama
2. Gerekirse IPR
3. Kapanış kontrolü

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sabit veya hareketli retainer

**Sık hata:** Sınırlı tedaviyle çözülemeyecek bir problemi sınırlı tedaviye sokmak.

**Detay:** Modül 03 · Klinik planlama

## PLAN 39 Karma dişlenmede ön bölge düzeltmesi (2×4)

**Tipik bulgular:** Karma dişlenme, kesicilerde çapraşıklık, rotasyon veya çapraz kapanış.

**Tedavi hedefleri:** Kesicileri hizalamak · Travma ve fonksiyon riskini azaltmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Daimi diş tomurcukları ve yer durumu
- Molar ilişkisi

### 2 · HEDEF VE KARAR

- Sınırlı, kısa bir faz; ikinci fazı aileye baştan anlatın

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Molar bant ve kesici braketleri
2. Hafif tellerle hizalama
3. Kök paralelliği

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Retainer ve ikinci faz takibi

**Sık hata:** Kanin tomurcuklarına yakın kökleri fark etmeden devirmek.

**Detay:** Modül 03 · Klinik planlama

## PLAN 40 Alt kesici çapraşıklığı · IPR ile çözüm

**Tipik bulgular:** Hafif alt kesici çapraşıklığı, dişler üçgen formlu, siyah üçgen riski.

**Tedavi hedefleri:** Çekimsiz hizalama · Siyah üçgenleri azaltmak

### 1 · TEŞHİS VE KAYIT

- Diş formu ve mine kalınlığı
- Dişeti papilla durumu
- Yer ihtiyacı

### 2 · HEDEF VE KARAR

- IPR miktarını yer analizine göre planlayın ve kaydedin

### 3 · MEKANİK SIRA

1. Hizalama
2. Planlanan IPR
3. Boşluk kapama

### 4 · BİTİRME VE PEKİŞTİRME

- Sabit lingual retainer

**Sık hata:** IPR'ı plansız ve kayıtsız yapmak.

**Detay:** Modül 04 · Yer yönetimi

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

# Sonraki adım

Planı seçtikten sonra **Ark Teli Sıralama Tabloları**'ndan uygun tel sırasını ve **Aparey Seçim Rehberi**'nden apareyi seçin. Planın gerekçesini derinleştirmek için Başucu Kitabı'nda **Modül 03 · Klinik planlama: problem listesinden mekaniğe** bölümüne dönün.